

CONFERENCE

2.4 - Processus traumatiques





Avant tout !



Aller hop on commence !

Généralités



Définissez une fracture ainsi que ses différents types



Définissez une fracture ainsi que ses différents types

Fracture : rupture complète/incomplète solution de continuité osseuse avec ou sans déplacement des fragments.

- **Complète**
- **Incomplète**
- **Déplacée**
- **Ouverte**



Citez quatre complications précoces des fractures



Citez quatre complications précoces des fractures

- **Lésions vasculaires: choc hémorragique**
- **Lésions nerveuses par compression**
- **Infection (fractures ouvertes)**
- **Syndrome des loges**
- **Complications thromboembolique (TVP & EP)**
- **Embolie graisseuse**
- **Rupture des organes internes**
- **Complications de décubitus (stases pulmonaires, intestinales, urinaires, troubles trophiques, fonte musculaire et raideurs articulaires)**
- **Rhabdomyolise**



Citez les différents traitements des fractures



Citez les différents traitement des fractures

- La **réduction** : remise en position anatomique de fragment osseux déplacé par une fracture ou par luxation
- Traitement **orthopédique**: attelles, orthèses, plâtre ou résine.
- Traitement **chirurgical**: ostéosynthèse (vis, broches, clou, plaque), fixateur externe

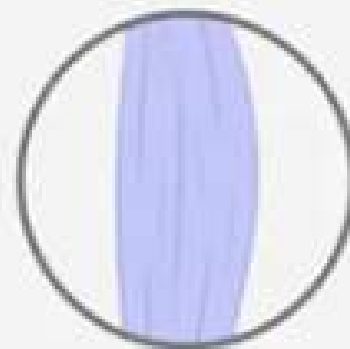


**Définissez une entorse et indiquez les
grades**

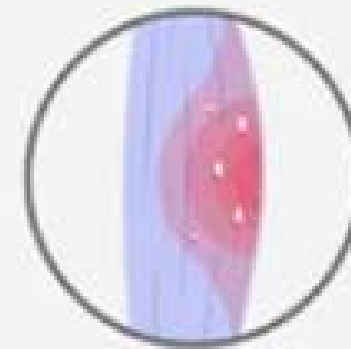


Définissez une entorse

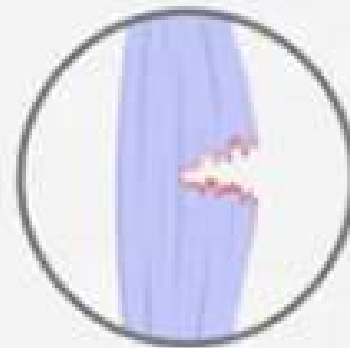
Entorse: lésion traumatique d'une articulation avec élongation ou arrachement des ligaments, sans déplacement permanent des surfaces articulaires



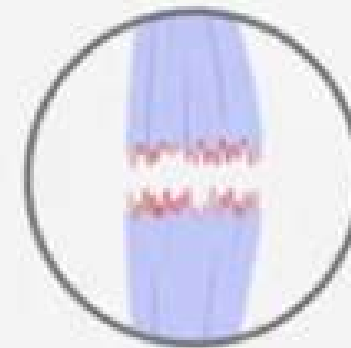
Ligament
sain



Lésion de
Grade 1



Lésion de
Grade 2



Lésion de
Grade 3

**Définissez une luxation et donnez des
locations fréquentes (3)**



Définissez une luxation et donnez les locations fréquentes (3)

Luxation : Déplacement des extrémités articulaires entraînant une modification permanente de leurs rapports.

Pertes permanentes des rapports normaux des surfaces articulaires.

- **Epaule**
- **Hanche**
- **Genou**



Les étapes de la consolidation osseuse :

- a. l'hématome/le cal osseux/le remaniement osseux/le cal fibrocartilagineux**
- b. l'hématome/le cal fibreux/le cal vicieux/le cal osseux/le remodelage**
- c. l'hématome/le cal fibrocartilagineux/le cal osseux/le remaniement osseux**
- d. le remaniement osseux/le cal osseux/le cal fibrocartilagineux/le remodelage**
- e. le cal osseux/le cal fibrocartilagineux/le remaniement osseux/l'hématome**



Les étapes de la consolidation osseuse :

- a. l'hématome/le cal osseux/le remaniement osseux/le cal fibrocartilagineux
- b. l'hématome/le cal fibreux/le cal vicieux/le cal osseux/le remodelage
- c. l'hématome/le cal fibrocartilagineux/le cal osseux/le remaniement osseux
- d. le remaniement osseux/le cal osseux/le cal fibrocartilagineux/le remodelage
- e. le cal osseux/le cal fibrocartilagineux/le remaniement osseux/l'hématome



L'hypothermie :

- A. Est fréquente chez les patients traumatisés graves**
- B. Est un facteur difficilement corrigeable**
- C. Peut aggraver l'état du patient**
- D. Augmente entre autres, les pertes sanguines par son action sur la coagulation**
- E. Augmente l'oxygénation du sang**

L'hypothermie :

A. Est fréquente chez les patients traumatisés graves

B. Est un facteur difficilement corrigeable

C. Peut aggraver l'état du patient

D. Augmente entre autres, les pertes sanguines par son action sur la coagulation

E. Augmente l'oxygénation du sang

Parmi ces affirmations, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s)?

- A. Le choc hémorragique est une complication tardive grave**
- B. L'embolie graisseuse est secondaire à une phlébite du membre inférieur**
- C. Le syndrome des loges peut évoluer vers le syndrome de volkman**
- D. La phlébite associe comme signes cliniques: oedème, chaleur, douleur du mollet à la dorsiflexion**
- E. Toutes les réponses ci-dessus sont vraies**

Parmi ces affirmations, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s)?

A. Le choc hémorragique est une complication tardive grave

B. L'embolie graisseuse est secondaire à une phlébite du membre inférieur

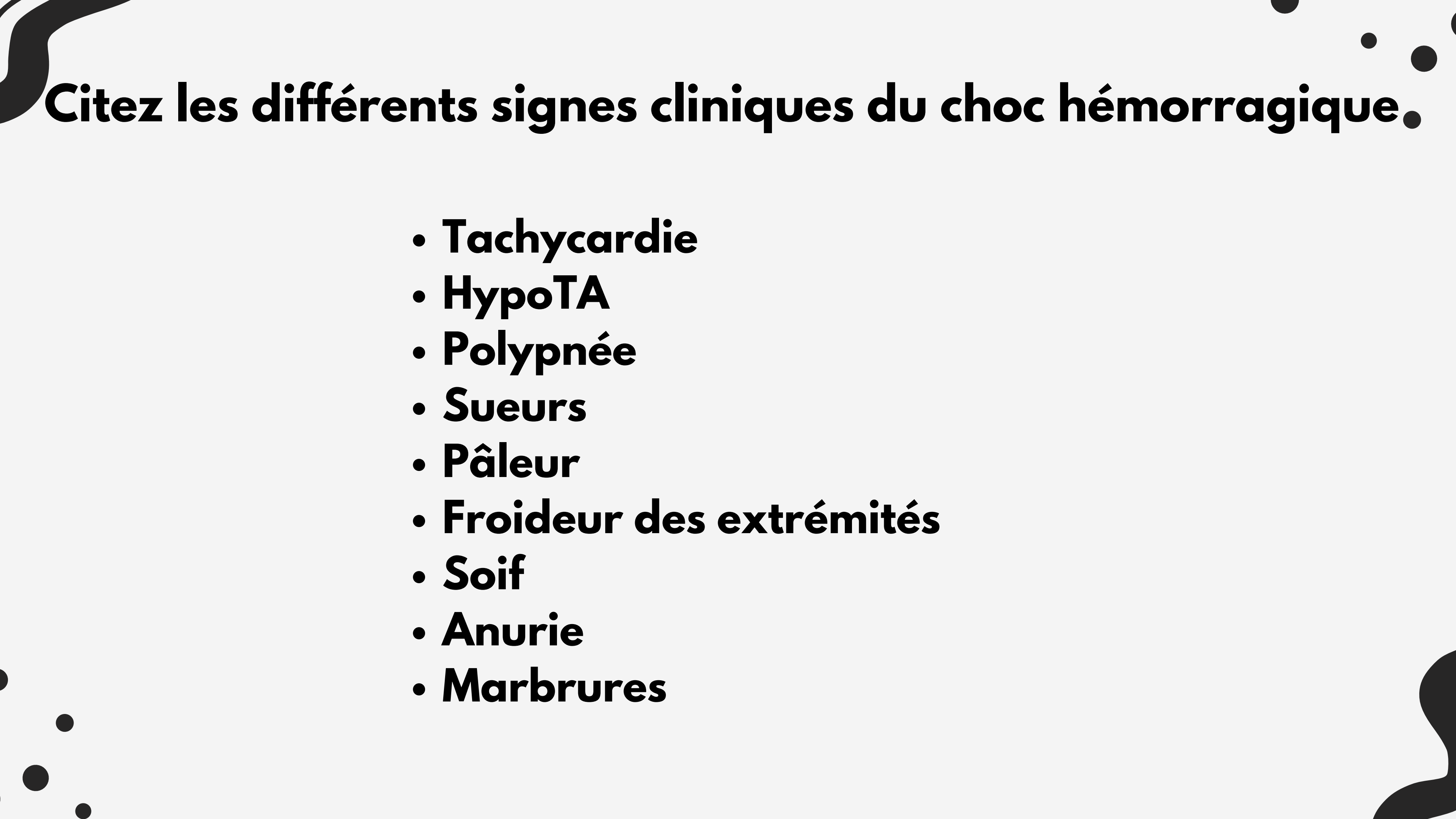
C. Le syndrome des loges peut évoluer vers le syndrome de volkman

D. La phlébite associe comme signes cliniques: oedème, chaleur, douleur du mollet à la dorsiflexion

E. Toutes les réponses ci-dessus sont vraies

**Citez les différents signes cliniques du choc
hémorragique (5 mini)**

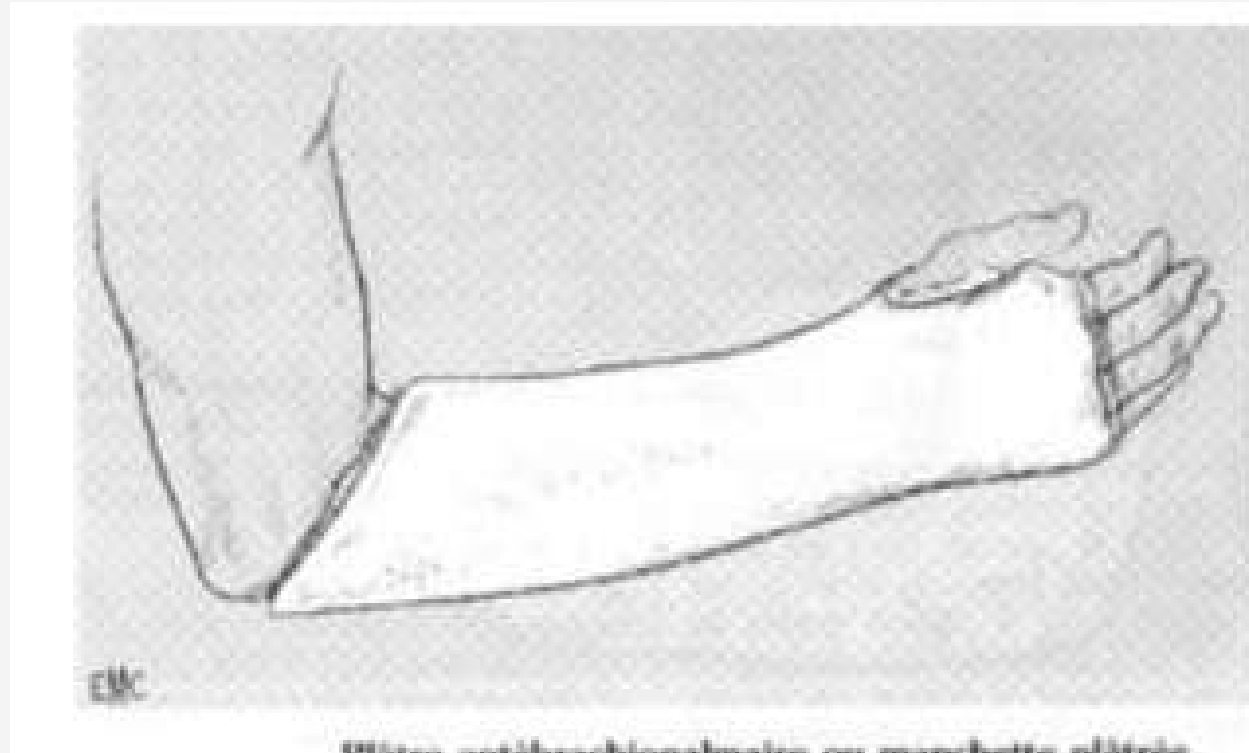




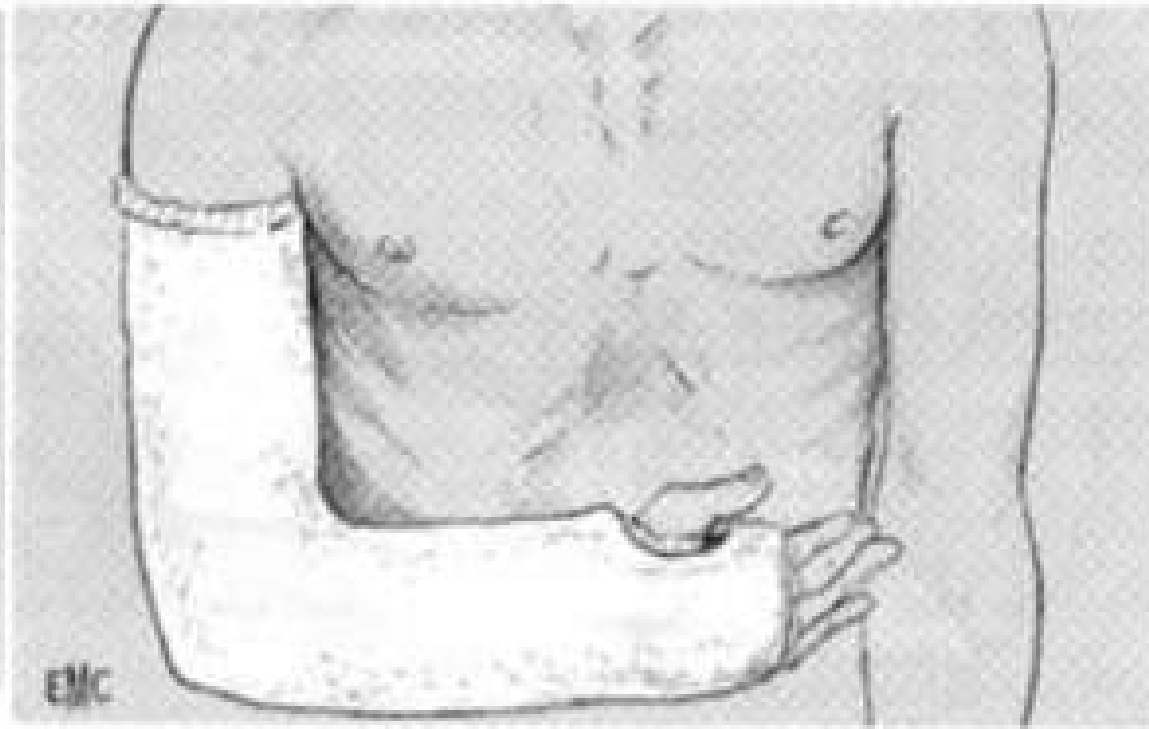
Citez les différents signes cliniques du choc hémorragique.

- **Tachycardie**
- **HypoTA**
- **Polypnée**
- **Sueurs**
- **Pâleur**
- **Froideur des extrémités**
- **Soif**
- **Anurie**
- **Marbrures**

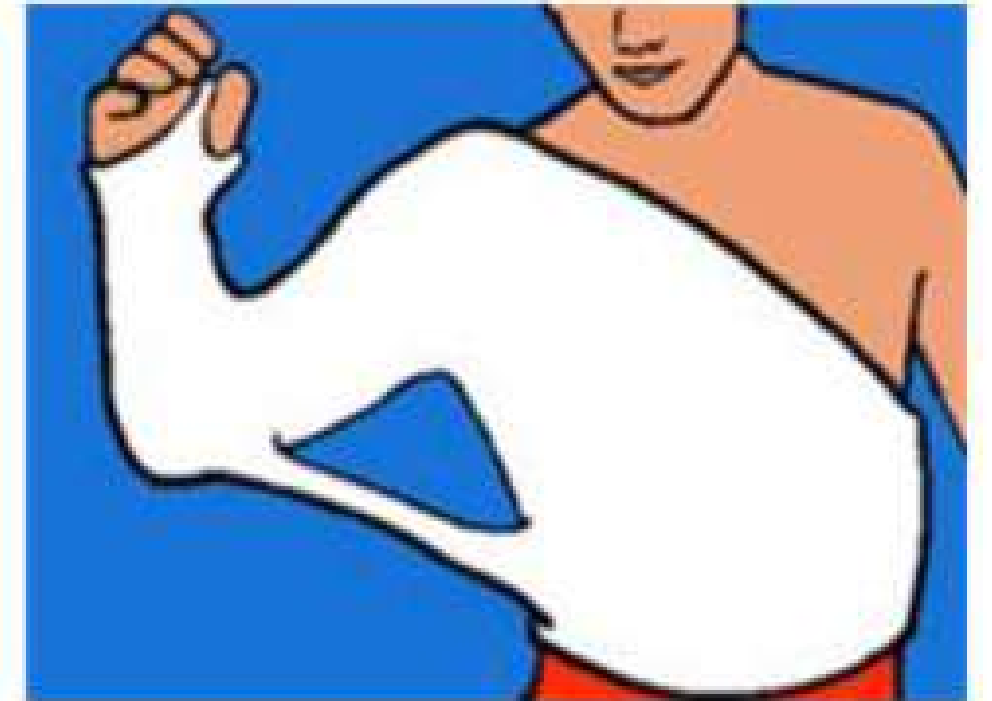
Quels sont les différents types de plâtres ?



1



2

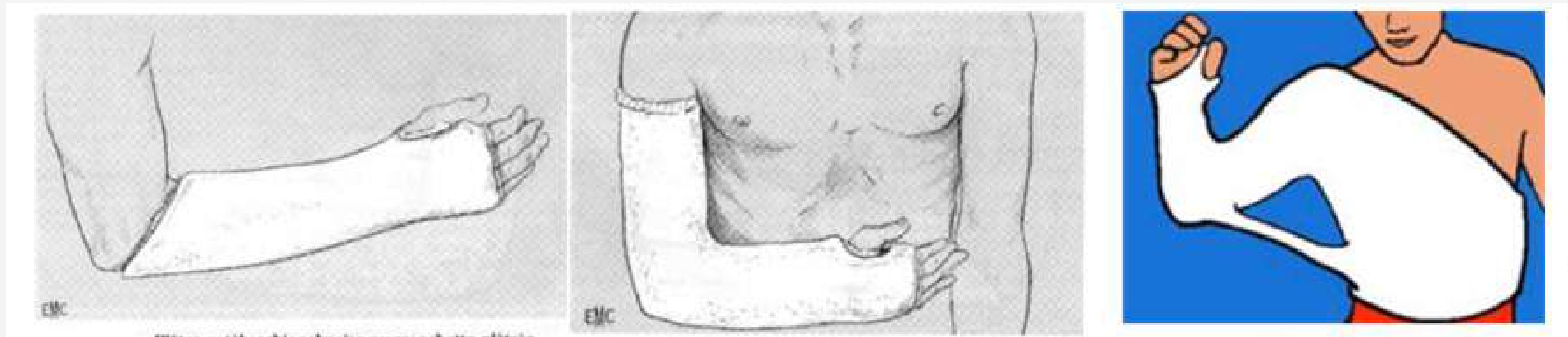


3



Un coup de pouce ?

- **Plâtre brachio-antébrachio-palmaire (poignet + coude + avant bras)**
- **Plâtre thoraco-brachial (peu utilisé)**
- **Plâtre antébrachial (poignet + carpe)**

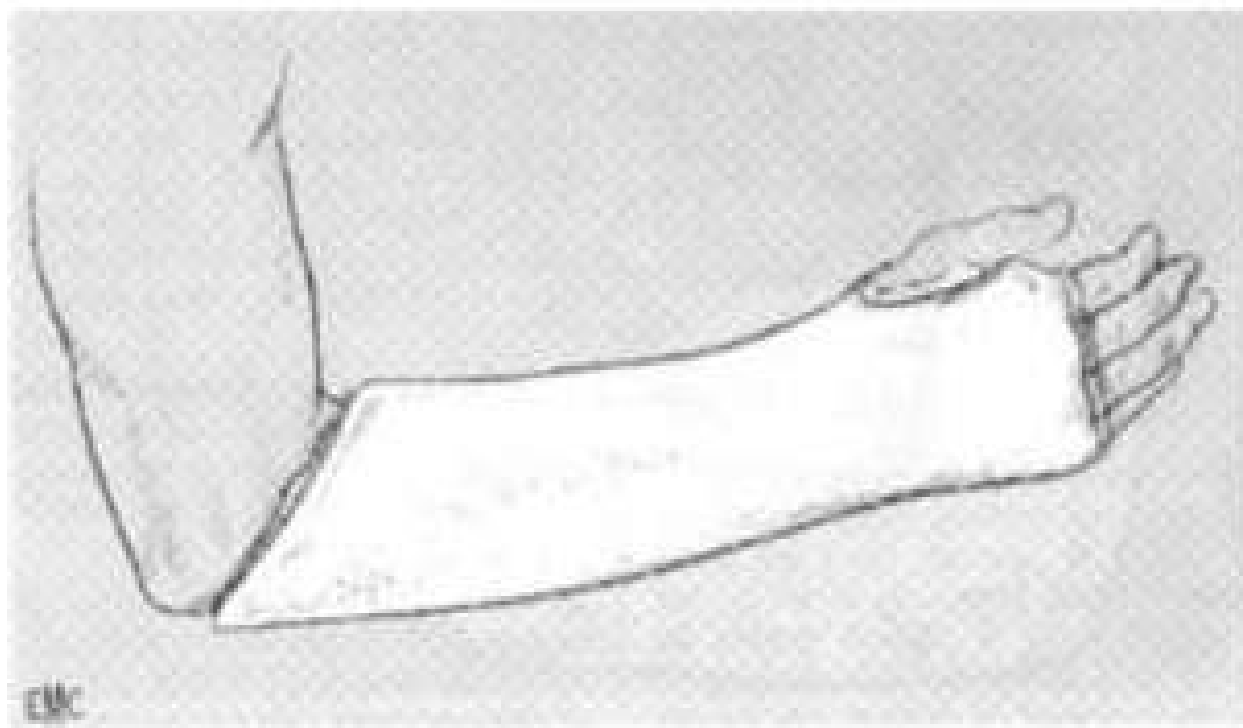


Les différents types de plâtres

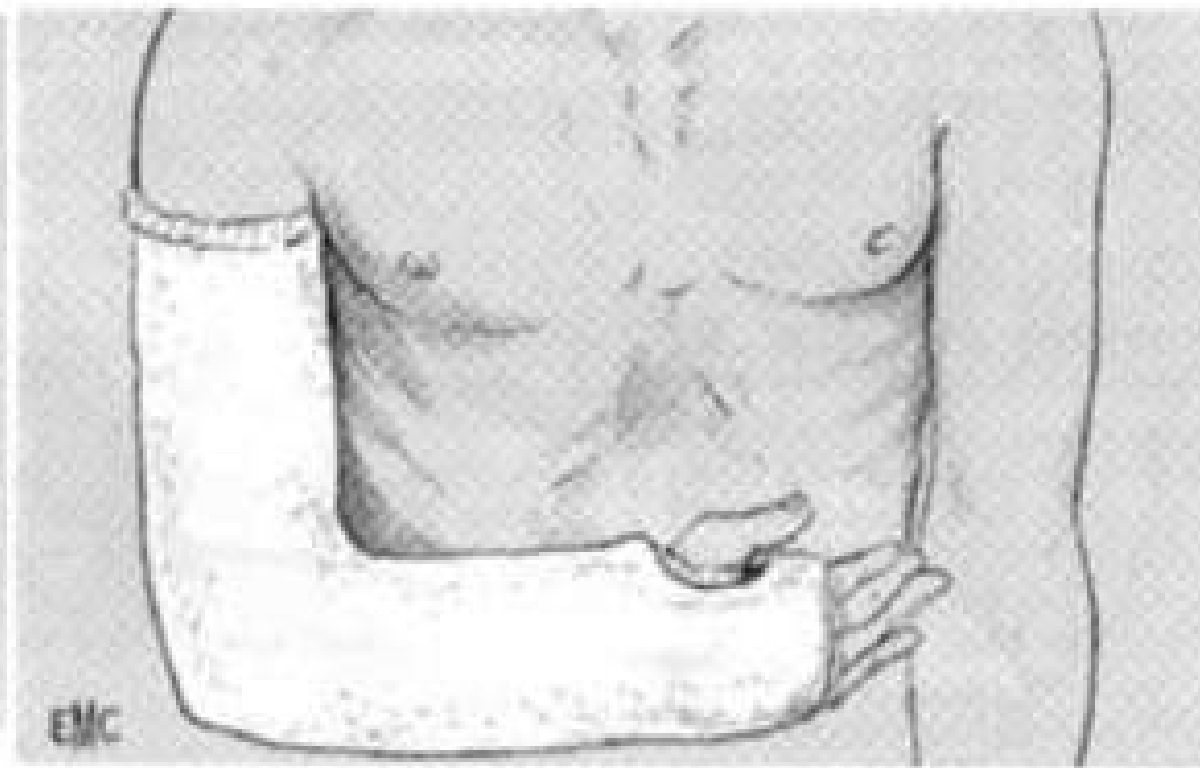
1

2

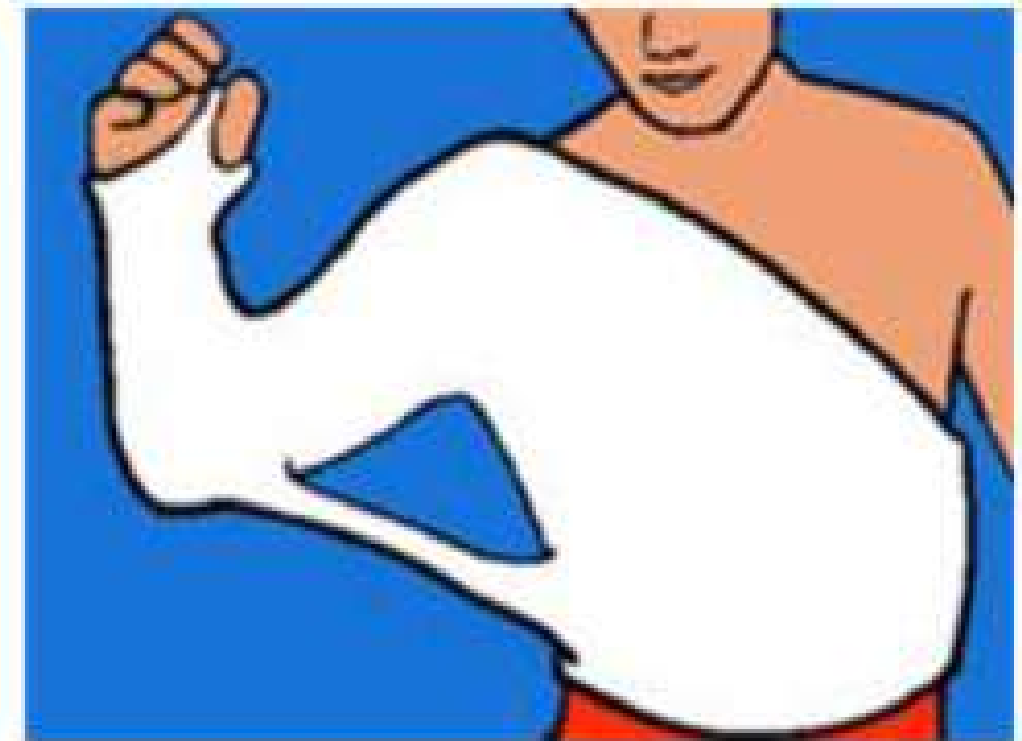
3



**Plâtre antébrachial
(poignet + carpe)**



**Plâtre brachio-antébrachio-
palmaire
(poignet + coude + avant bras)**



**Plâtre thoraco-brachial
(peu utilisé)**

**Quels sont les éléments de surveillance d'un membre
plâtrée? (7)**



Quels sont les éléments de surveillance d'un membre plâtrée? (7)

- **chaleur**
- **rougeur / couleur**
- **œdème**
- **douleur**
- **aspect de la peau**
- **mobilité**
- **sensibilité**

Parmi ces affirmations, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s)?

- A. Le syndrome des loges se manifeste par une douleur intense**
- B. Le syndrome des loges se manifeste par une absence de douleur**
- C. Le syndrome des loges est lié à la compression des muscles**
- D. Le syndrome des loges est provoqué par la destruction des fibres musculaires**
- E. Le seul traitement du syndrome des loges est la fasciotomie (l'aponévrectomie)**

Parmi ces affirmations, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s)?

- A. Le syndrome des loges se manifeste par une douleur intense**
- B. Le syndrome des loges se manifeste par une absence de douleur => douleur à type de crampe très intense, résistante aux ATG**
- C. Le syndrome des loges est lié à la compression des muscles**
- D. Le syndrome des loges est provoqué par la destruction des fibres musculaires => il s'agit de la rhabdomyolyse**
- E. Le seul traitement du syndrome des loges est la fasciotomie (l'aponévrectomie) => il existe d'autres traitement comme drainer**

Le syndrome des loges

Ischémie musculaire suite à une hyperpression dans sa loge anatomique inextensible

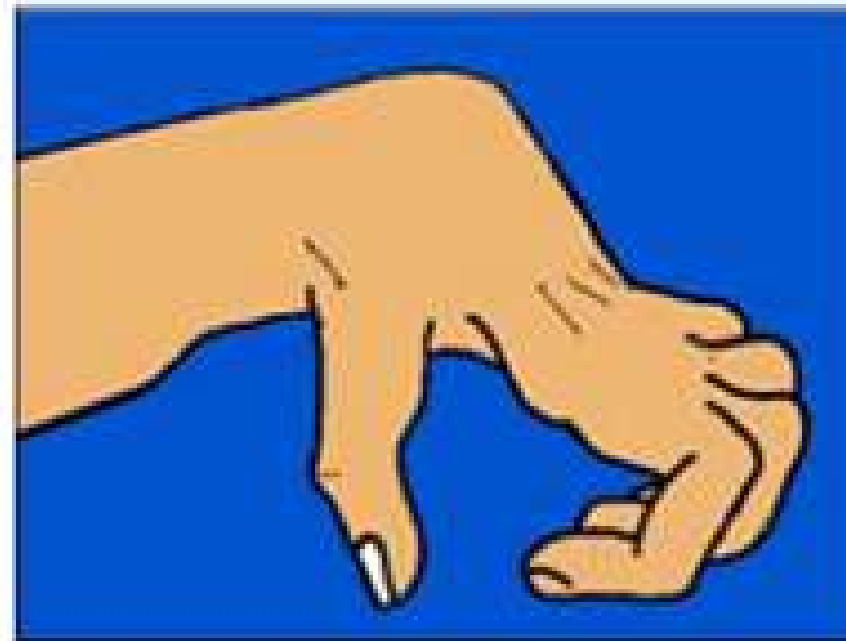
- **Mort cellulaire par ischémie**
- **Œdèmes**
- **Déficit de sensibilité à type de paresthésie**
- **Déficit moteur**
- **Douleur résistants aux ATG**



Le syndrome de Volkmann

Rétraction ischémique des muscles fléchisseurs par compression artérielle extrinsèque aboutissant à une main en griffe

- **Douleur**
- **Gonflement des doigts et des orteils (œdème)**
- **Changement de couleur et de température des extrémités**
- **Fourmillement des doigts, jusqu'à insensibilité**



Déformation avérée :

- Flexion du poignet
- Hyperextension des MP
- Flexion des IPP

La douleur



Définissez la douleur



La douleur

Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à, ou ressemblant à celle associée à, une lésion tissulaire réelle ou potentielle.



**Quelles sont les composantes de la douleur
(4)?**



Les composantes de la douleur

- **Sensorielle**
- **Affective et émotionnelle**
- **Cognitive**
- **Comportementale**



Quelles sont les différents types de douleurs? Selon la durée & le mécanisme



Les différents types de douleur

Selon le mécanisme:

- **Douleur par excès de nociception**
- **Douleur neuropathique**
- **Douleur nociplastique**

Selon la durée:

- **Douleur aiguë**
- **Douleur chronique**

**Avec quelles échelles pouvez-vous évaluer la douleur?
Quels outils pouvez-vous utiliser pour décrire une
douleur?**



Evaluation de la douleur

TILT => Type - Intensité - Localisation - Temporalité

Echelles d'autoévaluation: le patient est communicant, c'est lui qui évalue l'intensité de sa douleur:

- **EVS: Echelle verbale simple**
- **EN: Echelle numérique**
- **EVA: Echelle visuelle analogique**

Echelles d'hétéroévaluation: Le patient ne communique pas, c'est l'équipe qui évalue la douleur du patient en observant son comportement:

- **Algoplus**
- **Doloplus**
- **ECPA**

Patient bénéficiant d'une chirurgie



Citez les étapes de la préparation pré-opératoire



Citez les étapes de la préparation per opératoire

- **Pose de bracelet d'identification + IDENTITOVIGILANCE**
- **Douche ou toilette avec brossage de dents**
- **Vérification du jeûne (boisson claire 2h avant / nourriture 6h avant)**
- **Signaler la présence de tout appareil dentaire, auditif ou oculaire**
- **Prise des constantes: FC, PA, T°, FR, SaO2 (référence pour la suite: per op et post op)**
- **Ablation bijoux, piercing, maquillage, vernis si besoin**
- **Vérifier complétude dossier et fiche de liaison bloc**

**Quels sont les risques principaux à la suite
d'une chirurgie?**



Quels sont les risques principaux à la suite d'une chirurgie?

- **Risque hémorragique**
- **Risque de douleur**
- **Risque infectieux**
- **Risque thromboembolique**
- **Risque de complications de décubitus**
- **Risque de complications liés à l'anesth**
- **Risque d'inconfort psychologique**

Expliquez le rôle des examens pré-op suivants:

- **NFS**
- **Coag**
- **lono**
- **Rx pulmonaire**
- **RAI + Phénotypes + culots globulaires**



NFS

**NFS: permet de mesurer les différents éléments figurés du sang,
le taux d'hémoglobine et le taux d'hématocrite.**

**=> repérer une anémie et mettre en évidence une éventuelle
hémorragie ou la constitution d'un hématome**

**=> recherche d'une éventuelle hyperleucocytose ou une
leucopénie**

=> Recherche d'une thrombopénie (taux de plaquettes)

=> Faire un bilan de référence

Coagulation

bilan d'hémostase pré opératoire dans un contexte d'intervention chirurgicale à risque hémorragique. L'objectif est de s'assurer de la qualité de la coagulation sanguine afin, en per opératoire, d'être en mesure de juguler dans de bonnes conditions une éventuelle hémorragie. Une anomalie de coagulation décelée en pré opératoire demande des investigations supplémentaires, un éventuel traitement et engendre la suspension ou le différé de l'intervention.

Ionogramme sanguin

**Apprécie le bilan hydro électrolytique à la recherche d'un déséquilibre éventuel pouvant générer un dysfonctionnement majeur d'un ou de plusieurs organes (rein, cœur, poumons...).
Bilan de base afin d'éliminer toute contre-indication à l'anesthésie générale.**



Radio pulmonaire

**examen de base avant une AG pour une personne âgée.
Permet d'apprécier la capacité pulmonaire de la patiente et de
repérer d'éventuelles anomalies incompatibles avec une AG**



RAI & Phénotypes + Culots globulaires

RAI + phénotypes : pour savoir le groupe sanguin du patient et de prévoir des CGR

l'intervention présentant un risque hémorragique, il est nécessaire d'anticiper le risque et de prévoir des culots globulaires rapidement disponibles et susceptibles de suppléer la perte sanguine.



Plaies et brûlures



**Parmi les plaies mentionnées ci-après, lesquelles
sont des plaies aiguës ?**

- A. Les escarres**
- B. Les brûlures**
- C. Les gelures**
- D. Les morsures**
- E. Les plaies du diabétique**



**Parmi les plaies mentionnées ci-après, lesquelles
sont des plaies aiguës ?**

A. Les escarres

B. Les brûlures

C. Les gelures

D. Les morsures

E. Les plaies du diabétique



Parmi les plaies mentionnées ci-après, lesquelles sont des plaies traumatiques ?

- A. Les greffes de peau**
- B. Les excisions**
- C. Les dermabrasions**
- D. Les coupures**
- E. Les dilacérations**



Parmi les plaies mentionnées ci-après, lesquelles sont des plaies traumatiques ?

A. Les greffes de peau

B. Les excisions

C. Les dermabrasions

D. Les coupures

E. Les dilacérations



Parmi les plaies mentionnées ci-après, lesquelles sont des plaies chroniques ?

- A. Les brûlures**
- B. L'ulcère veineux**
- C. L'incision**
- D. Les dermabrasions**
- E. Une plaie d'escarre de stade 3/4**



Parmi les plaies mentionnées ci-après, lesquelles sont des plaies chroniques ?

A. Les brûlures

B. L'ulcère veineux

C. L'incision

D. Les dermabrasions

E. Une plaie d'escarre 3/4



**Une des complications suivantes ne concerne pas
les personnes atteintes de brûlures :**

a. embolie pulmonaire

b. insuffisance rénale

c. infection

d. déshydratation

e. choc hypovolémique



Une des complications suivantes ne concerne pas les personnes atteintes de brûlures :

a. embolie pulmonaire

b. insuffisance rénale

c. infection

d. déshydratation

e. choc hypovolémique



Citez les différents degré de brûlures ainsi que leur atteintes



Citez les différents degré de brûlures ainsi que leur atteintes

- **1^{er} degré: Epiderme**
- **2nd degré (2nd degré superficiel / 2nd degré profond) : Derme**
- **3^{ème} degré: Hypoderme**

“ Une brulure moins elle est douloureuse plus cela est potentiellement grave car atteinte nerveuse potentielle ”

Parmi les facteurs cités ci-après lesquels influence la cicatrisation ?

- A. Les caractéristiques de la plaie**
- B. L'hydratation de la plaie**
- C. La vascularisation de la plaie**
- D. Le tabagisme**
- E. Toutes les réponses ci-dessus**



Parmi les facteurs cités ci-après lesquels influence la cicatrisation ?

- A. Les caractéristiques de la plaie**
- B. L'hydratation de la plaie**
- C. La vascularisation de la plaie**
- D. Le tabagisme**
- E. Toutes les réponses ci-dessus**



Traumatisme thoracique



Parmi ces affirmations, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s)?

- A. Les traumatismes thoraciques sont très rares**
- B. Les traumatismes thoraciques sont souvent isolés**
- C. Les lésions thoraciques sont secondaires à un écrasement de la cage thoracique**
- D. Les lésions thoraciques sont secondaires à une décélération importante**
- E. Le blast est responsable de contusion pulmonaire**

Parmi ces affirmations, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s)?

- A. Les traumatismes thoraciques sont très rare => Ils sont très fréquents, représente $\frac{1}{3}$ des admissions en traumatologie**
- B. Les traumatismes thoraciques sont souvent isolés => souvent associés à des polytraumatismes**
- C. Les lésions thoraciques sont secondaires à un écrasement de la cage thoracique**
- D. Les lésions thoraciques sont secondaires à une décélération importante**
- E. Le blast est responsable de contusion pulmonaire => par hyperpression secondaire à l'explosion**

Quels traumatismes peuvent entraîner une détresse respiratoire?

- A. un pneumothorax compressif**
- B. une lésions médullaire au dessus de C4**
- C. un hémothorax**
- D. un hémopneumothorax**
- E. Toutes les réponses ci-dessus**



Quels traumatismes peuvent entraîner une détresse respiratoire?

- A. un pneumothorax compressif
- B. une lésions médullaire au dessus de C4
- C. un hémothorax
- D. un hémopneumothorax
- E. Toutes les réponses ci-dessus



Quelles sont les propositions exactes?

- A. Un pneumothorax ne survient jamais après un traumatisme thoracique**
- B. Un pneumothorax peut-être bien toléré**
- C. le pneumothorax compressif est lié à une médiation médiastinale qui comprime le poumon controlatérale**
- D. le pneumothorax compressif entraîne une détresse respiratoire et une détresse circulatoire**
- E. l'exsufflation complétée par un drainage thoracique est le traitement du pneumothorax suffocant**



Quelles sont les propositions exactes?

- A. Un pneumothorax ne survient jamais après un traumatisme thoracique
- B. Un pneumothorax peut-être bien toléré
- C. le pneumothorax compressif est lié à une médiation médiastinale qui comprime le poumon controlatérale
- D. le pneumothorax compressif entraîne une détresse respiratoire et une détresse circulatoire
- E. l'exsufflation complétée par un drainage thoracique est le traitement du pneumothorax suffocant

Traumatisme crânien & du rachis



Le score de Glasgow :

- A. Le score de Glasgow est utilisé pour évaluer la gravité d'un traumatisme crânien**
- B. L'utilisation du score de Glasgow est suffisante pour évaluer l'importance d'un traumatisme crânien**
- C. Le score de Glasgow s'établit sur 25 points**
- D. Le score de vigilance évalue, entre autres, l'ouverture des yeux**
- E. Un patient qui n'a aucune réactivité verbale, oculaire ou motrice à un score de Glasgow à 5**

Le score de Glasgow :

- A. Le score de Glasgow est utilisé pour évaluer la gravité d'un traumatisme crânien**
- B. L'utilisation du score de Glasgow est suffisante pour évaluer l'importance d'un traumatisme crânien**
- C. Le score de Glasgow s'établit sur 25 points**
- D. Le score de vigilance évalue, entre autres, l'ouverture des yeux**
- E. Un patient qui n'a aucune réactivité verbale, oculaire ou motrice à un score de Glasgow à 5**

L'anatomie du rachis :

- A. Le rachis est composé de 43 vertèbres**
- B. Le rachis cervical comporte 5 vertèbres notées de C1 à C5**
- C. Le rachis dorsal se nomme aussi rachis thoracique**
- D. Le rachis thoracique est composé des vertèbres T1 à T12**
- E. Le sacrum est la dernière vertèbre du rachis lombaire**



L'anatomie du rachis :

- A. Le rachis est composé de 43 vertèbres**
- B. Le rachis cervical comporte 5 vertèbres notées de C1 à C5**
- C. Le rachis dorsal se nomme aussi rachis thoracique**
- D. Le rachis thoracique est composé des vertèbres T1 à T12**
- E. Le sacrum est la dernière vertèbre du rachis lombaire**



Un choc spinal :

- A. Correspond à l'abolition de tous les réflexes en dessous de la lésion médullaire**
- B. Correspond à une lésion médullaire complète**
- C. Est une lésion secondaire**
- D. Est accompagné d'une rétention d'urine et d'une atonie du sphincter anal**
- E. Se traduit par un syndrome de la queue de cheval**

Un choc spinal :

- A. Correspond à l'abolition de tous les réflexes en dessous de la lésion médullaire**
- B. Correspond à une lésion médullaire complète**
- C. Est une lésion secondaire**
- D. Est accompagné d'une rétention d'urine et d'une atonie du sphincter anal**
- E. Se traduit par un syndrome de la queue de cheval**

Quels sont les examens biologiques et radiologiques à réaliser en urgence lors d'un traumatisme crânien :

- a. la numération formule sanguine**
- b. le scanner thoracique**
- c. la scintigraphie osseuse**
- d. les marqueurs de la coagulation**
- e. le scanner crânien**



Quels sont les examens biologiques et radiologiques à réaliser en urgence lors d'un traumatisme crânien :

- a. la numération formule sanguine
- b. le scanner thoracique
- c. la scintigraphie osseuse
- d. les marqueurs de la coagulation
- e. le scanner crânien



Quelles lésions sont associées aux traumatismes crâniens jusqu'à preuve du contraire :

- a. des lésions rénales**
- b. des lésions thoraciques**
- c. des lésions du rachis**
- d. des lésions abdominales**
- e. des lésions cardiaques**



Quelles lésions sont associées aux traumatismes crâniens jusqu'à preuve du contraire :

- a. des lésions rénales**
- b. des lésions thoraciques**
- c. des lésions du rachis**
- d. des lésions abdominales**
- e. des lésions cardiaques**



A propos des lésions méningées:

- A. Les méninges sont de l'extérieur à l'intérieur: la dure-mère, la pie-mère et l'arachnoïde**
- B. l'hématome extradural est un épanchement de sang situé entre la dure-mère et l'os du crâne**
- C. l'hématome sous-dural est un épanchement de sang situé entre la dure-mère et l'os du crâne**
- D. l'hémorragie méningée est un épanchement sanguin situé sous l'arachnoïde**
- E. l'hématome intra cérébrale est un collection de sang intraparenchymateuse**

A propos des lésions méningées:

- A. Les méninges sont de l'extérieur à l'intérieur: la dure-mère, la pie-mère et l'arachnoïde**
- B. l'hématome extradural est un épanchement de sang situé entre la dure-mère et l'os du crâne**
- C. l'hématome sous-dural est un épanchement de sang situé entre la dure-mère et l'os du crâne**
- D. l'hémorragie méningée est un épanchement sanguin situé sous l'arachnoïde**
- E. l'hématome intra cérébrale est un collection de sang intraparenchymateuse**

Quelles sont les propositions exactes?

- A. L'hématome sous-dural est une lésion cérébrale primaire**
- B. L'hématome sous-dural est une lésion cérébrale secondaire**
- C. La commotion cérébrale se traduit par une perte brutale et transitoire de connaissances associée à une amnésie**
- D. La commotion cérébrale est visible au scanner**
- E. La contusion cérébrale est une lésion macroscopique de l'encéphale**



Quelles sont les propositions exactes?

- A. L'hématome sous-dural est une lésion cérébrale primaire**
- B. L'hématome sous-dural est une lésion cérébrale secondaire**
- C. La commotion cérébrale se traduit par une perte brutale et transitoire de connaissances associée à une amnésie**
- D. La commotion cérébrale est visible au scanner**
- E. La contusion cérébrale est une lésion macroscopique de l'encéphale**



Traumatisme membres supérieurs



Une fracture de la clavicule :

- A. Peut être la conséquence d'une chute sur le moignon de l'épaule**
- B. Peut s'accompagner de lésions cutanées**
- C. Est une fracture généralement bénigne**
- D. N'est jamais accompagnée de lésions vasculo-nerveuses**
- E. Nécessite généralement un traitement orthopédique**



Une fracture de la clavicule :

- A. Peut être la conséquence d'une chute sur le moignon de l'épaule**
- B. Peut s'accompagner de lésions cutanées**
- C. Est généralement une fracture généralement bénigne**
- D. N'est jamais accompagnée de lésions vasculo-nerveuses**
- E. Nécessite généralement un traitement orthopédique**



Traumatisme membres inférieurs



Chez un patient opéré du membre inférieur, certains signes peuvent apparaître et doivent faire suspecter un accident thromboembolique :

- A. Une douleur du mollet**
- B. Une douleur du mollet majorée en dorsiflexion de la cheville**
- C. Un bilan sanguin perturbé (d-dimères)**
- D. Une fièvre à 40°C**
- E. Une tachycardie**



Chez un patient opéré du membre inférieur, certains signes peuvent apparaître et doivent faire suspecter un accident thromboembolique :

A. Une douleur du mollet

B. Une douleur du mollet majorée en dorsiflexion de la cheville

C. Un bilan sanguin perturbé (d-dimères)

D. Une fièvre à 40°C

E. Une tachycardie



La complication majeure après une arthroplastie de la hanche (PTH) est :

- a. l'ostéoporose**
- b. l'embolie graisseuse**
- c. l'embolie pulmonaire**
- d. la luxation**
- e. l'infection**



La complication majeure après une arthroplastie de la hanche (PTH) est :

- a. l'ostéoporose**
- b. l'embolie graisseuse**
- c. l'embolie pulmonaire**
- d. la luxation**
- e. l'infection**

La A/C/E sont aussi des complications de PTH

Quelles sont les complications d'une fracture tibia / fibula ?

- a. une phlébite**
- b. une infection**
- c. la formation d'un cal vicieux de la cheville**
- d. une rupture du tendon d'Achille**
- e. toutes les réponses ci-dessus**



Quelles sont les complications d'une fracture tibia / fibula ?

- a. une phlébite
- b. une infection
- c. la formation d'un cal vicieux de la cheville
- d. une rupture du tendon d'Achille
- e. toutes les réponses ci-dessus



Le tableau clinique d'une luxation de hanche peut montrer :

- a. une déformation du membre inférieur avec une abduction**
- b. une atteinte du nerf crural**
- c. une atteinte du nerf sciatique**
- d. une impotence fonctionnelle majeure**
- e. toutes les réponses ci-dessus**



Le tableau clinique d'une luxation de hanche peut montrer :

- a. une déformation du membre inférieur avec une abduction**
- b. une atteinte du nerf crural**
- c. une atteinte du nerf sciatique**
- d. une impotence fonctionnelle majeure**
- e. toutes les réponses ci-dessus**



Cltez les signes cliniques d'une fracture du col du fémur



Cltez les signes cliniques d'une fracture du col du fémur

- **Impotence fonctionnelle**
- **Douleur**
- **Déformation du membre qui est raccourci, en légère flexion et en rotation externe**



Quelle est la population la plus à risque d'une fracture du col du fémur? Pourquoi?



Quelle est la population la plus à risque d'une fracture du col du fémur? Pourquoi?

**La population la plus à risque sont les personnes âgées à cause de leur mobilité physique réduite et donc le risque de chute accrue.
Notamment les femmes âgées dû à l'ostéoporose suite à la ménopause qui entraîne une carence en oestrogène**



Traumatisme abdo-pelvien



Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie?

- A. la splénectomie est le seul traitement des lésions traumatiques de la rate**
- B. un traumatisme splénique peut entraîner un choc hémorragique**
- C. En cas de traumatisme splénique, la splénectomie n'est jamais indiquée**
- D. Un traumatisme splénique ne donne jamais de traumatisme**
- E. La splénectomie est une ablation de la rate**



Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie?

- A. la splénectomie est le seul traitement des lésions traumatiques de la rate**
- B. un traumatisme splénique peut entraîner un choc hémorragique**
- C. En cas de traumatisme splénique, la splénectomie n'est jamais indiquée**
- D. Un traumatisme splénique ne donne jamais de traumatisme**
- E. La splénectomie est une ablation de la rate**



Citez les examens d'imagerie utiles pour rechercher les lésions abdominales/pelviennes



Citez les examens d'imagerie utiles pour rechercher les lésions abdominales/pelviennes

- **Echographie**
- **Scanner**
- **Doppler des artères rénales**
- **Radiographie**



Polytraumatisé



Définir le polytraumatisé



Définir le polytraumatisé

Polytraumatisé: blessé grave ayant subi un traumatisme violent, présentant une association de lésions multiples dont une au moins qui engage le pronostic vital immédiatement ou à court terme

Polytraumatisé ≠ polyfracturé ≠ polyblessé



Quelles sont les lésions les plus fréquemment observées chez un polytraumatisé :

- a. les lésions cervicales**
- b. les lésions orthopédiques**
- c. les lésions thoraciques**
- d. les traumatismes crâniens**
- e. les lésions urologiques**



Quelles sont les lésions les plus fréquemment observées chez un polytraumatisé :

- a. les lésions cervicales
- b. les lésions orthopédiques
- c. les lésions thoraciques
- d. les traumatismes crâniens
- e. les lésions urologiques



CONFERENCE

2.4 - Processus traumatiques

Merci !

